

Optilume علاج طفيف التوغل لتضييق (stricture) الإحليل — الأنبوب الذي يخرج البول من جسمك. يُوسّع بالون خاص المنطقة الضيقة ويُطلق في الوقت ذاته دواءً في جدارها للحدّ من تنديبها مجدداً. لا قطع ولا شقّ خارجي.

عن هذا الإجراء

تضييق الإحليل (stricture) هو مقطع منتدب ضيق يُبطئ تدفق البول. التمدد أو التشريط وحده كثيراً ما يسمح بعودة التضييق. يؤدي Optilume دورين معاً:

- البالون يُوسّع المقطع المنتدب.
- الطلاء الدوائي (paclitaxel) على البالون ينتقل إلى الأنسجة لإبطاء تكوّن الندبة من جديد.

يُعدّ خياراً مناسباً لتضيقات الإحليل الكُوري (تحت كيس الصفن) المتكررة التي لا تتجاوز نحو 3 سم وعادت بعد تمدد أو تشريط سابق. إنه أكثر ديمومةً من التمدد البسيط، غير أنه ليس بديلاً عن رأب الإحليل (الإصلاح المفتوح) الذي يمنح أعلى نسبة ديمومة. سيشرح لك جرّاحك مدى ملاءمته لحالتك.

هل هو آمن؟

Optilume طفيف التوغل ويُجرى عبر الإحليل، وغالباً كإجراء خارجي في نفس اليوم. جرعة الدواء صغيرة وتبقى موضعية. تشمل المخاطر: دم في البول أو المنّي، حرقّة عابرة، عدوى في البول، وإمكانية عودة التضييق بمرور الوقت.

تعلم المصطلحات

الإحليل

الأنبوب الذي يُخرج البول من الجسم.

Stricture (التضييق)

مقطع منتدب ضيق في الإحليل يُبطئ تدفق البول.

الإحليل الكُوري

الجزء من الإحليل الواقع تحت كيس الصفن، حيث يُحقّق هذا العلاج أفضل النتائج.

البالون المغلف بالدواء

بالون يُوسّع التضييق ويوصل الدواء إلى الجدار.

Paclitaxel

الدواء الموجود على البالون الذي يُساعد على منع عودة الندبة.

التمدّد (Dilation)

توسيع التضييق — يُجرى هنا بالبالون.

المنظار (Cystoscope)

كاميرا رفيعة تُستخدم لتحديد التضييق وفحصه.

القسطرة (Catheter)

أنبوب ناعم يُوضع في الإحليل لفترة قصيرة بعد الإجراء.

هل سيولم؟ يُجرى الإجراء تحت التخدير أو التهدئة، فلا تشعر بشيء أثناءه. بعده، توقع حرقّة خفيفة وألماً في منطقة الحوض أو القضيب ودماً قليلاً في البول أو المنّي لأيام قليلة. تُوضع قسطرة لفترة قصيرة عادةً. الإجراء سريع ويُعادر أغلب المرضى في نفس اليوم.

كيف تستعدّ (قبل الإجراء)

بعد الإجراء

- اتّبع تعليمات التخدير أو التهدئة (الصيام وإيقاف الأدوية المحددة بما فيها مميّعات الدم).
- فحص البول للتحقق من غياب العدوى — يجب علاجها أولاً إن وُجدت.
- رتّب وسيلة إيصال للمنزل واستعدّ لوضع قسطرة لفترة وجيزة.

أخبر فريقك الطبي مسبقاً إذا كنت:

- تتناول مميّع دم، أو لديك عدوى بولية حالية
- تخطّط للإنجاب — بسبب الدواء، ستُطلب منك استخدام الواقي الذكري وتجنّب الإنجاب للمدة التي يحددها فريقك

ما الذي يحدث أثناء الإجراء

- 1 أنت نائم أو مُهدأ، ويؤكد المنظار طول التضييق وموقعه.
- 2 يُمرّر سلك رفيع عبر التضييق وتُوسّع المنطقة قليلاً لإدخال البالون.
- 3 يُمرّز البالون المغلف بالدواء عبر الندبة ويُنفخ لمدة محددة لإيصال الدواء.
- 4 يُسحب البالون والمنظار وتُوضع قسطرة لفترة قصيرة.

اتصل بفريقك الطبي إذا كان لديك:

- حمّى أو قشعريرة
- عجز عن التبوّل، خاصةً بعد إزالة القسطرة
- نزيف غزير أو جلطات دموية في البول
- ألم يزداد سوءاً بدلاً من التحسّن

ثلاثة أمور تذكّرها

1. Optilume يُوسّع تضيق الإحليل بالبالون ويُوصل دواءً للحدّ من عودة الندبة — خيار منظارى وليس بديلاً عن رأب الإحليل المفتوح.
2. للتحضير: اتّبع تعليمات الصيام والأدوية، عالج أي عدوى أولاً، رتّب وسيلة إيصال، وأخبر فريقك إن كنت تخطّط للإنجاب.
3. الحرقّة الخفيفة ودم قليل في البول أو المنّي لأيام عدة أمر طبيعى. استخدم الواقي للمدة المحددة، واتصل فوراً عند الحمّى أو النزيف الغزير أو العجز عن التبوّل.